

Un adulto autistico anziano nel vostro ambulatorio

Per medici di famiglia e professionisti sanitari — nella cura di un adulto autistico anziano (circa 60+ anni).

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di un adulto anziano si è sempre bloccata in pochi „tunnel” profondi e intensi. Questa è la **parte meno studiata del ciclo di vita autistico**, e gli esiti sono preoccupanti: gli adulti autistici anziani hanno **tassi più alti della maggior parte delle condizioni di salute, bassa qualità della vita e limitata partecipazione sociale**. Molti non sono mai stati identificati — la „generazione perduta” — e arrivano attraverso differenze sociali/sensoriali di tutta la vita, burnout o crisi. Gli interessi e le routine di una vita sono ancora di benessere; i cambiamenti di udito e vista si sommano alle differenze sensoriali di base.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
Evita le cure, manca gli appuntamenti, „non gli piace venire”	Esperienze negative di una vita + barriere sensoriali/comunicative — non mancata osservanza
Declino delle abilità, esaurimento, ritiro	Possibile burnout autistico accumulato in decenni — spesso letto come „invecchiamento”
Risposte lente, insolite; sembra confuso	Spesso tempo di elaborazione + differenza autistica di una vita — non necessariamente demenza
Routine, oggetti, interessi forti; resiste al cambiamento	Sono ancore protettive per identità e cognizione
Non riferisce dolore o sintomi	Differenze di interocezione ; „non si lamenta” ≠ „non soffre”

Provate questo

- **Offrite l'AHAT di AASPIRE**; permettete un accompagnatore di fiducia; fornite informazioni **scritte e letterali** e ampio tempo di elaborazione.
- **Abbassate il carico sensoriale** e tenete conto della perdita di udito/vista che si somma alle differenze di base.
- **Protegete gli interessi e le routine di una vita**; adattate le attività alle capacità che cambiano invece di rimuoverle.
- **Distinguetе con cura la differenza autistica dal declino cognitivo** — le evidenze su autismo + demenza sono scarse; valutate, non date per scontato.
- **Documentate gli adeguamenti efficaci** così che siano automatici la prossima volta.

Evitate questo

- Liquidare differenze sociali/sensoriali di una vita come „solo invecchiamento”, o il burnout come depressione.
- Disruptare le routine o rimuovere oggetti significativi in ospedale/case di cura.

- Dare per scontata l'incapacità cognitiva da una risposta lenta o atipica — usate la presa di decisione supportata.

Quando serve altro supporto

Screenate il **burnout autistico** (spesso decenni nella formazione) e trattatelo come distinto dalla depressione. Guardatevi dalle **co-occorrenze comuni** — disturbi dell'umore, sonno, problemi gastrointestinali e cardiaci — più frequenti in questo gruppo. Affrontate l'**isolamento sociale** (un rischio maggiore) e incoraggiate un'attività dolce e su misura. Siate trasparenti sui **limiti delle evidenze** in vecchiaia e pianificate la cura avanzata con comunicazione chiara e letterale.

Se la persona è una donna

Le donne autistiche anziane sono un gruppo particolarmente sotto-identificato, avendo mascherato per una vita. Una storia di „ansia“, diagnosi errate o burnout accanto a differenze sociali/sensoriali di una vita merita seria considerazione dell'autismo.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la sintesi sul **Monotropismo** e la guida **Lifespan per professionisti e sanitari** (Parte 3.5 e 4). Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico.** Nota: le evidenze sull'autismo in vecchiaia sono scarse; trattatele come guida di buona pratica, e siate onesti sull'incertezza.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Dwyer (2025); Klein et al. (2024, revisione su invecchiamento e autismo); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024); AASPIRE AHAT; OAR (aging on the spectrum). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.